



3

56. ÅRGANG | 03 • 2019

ARTIKEL

Tema

Når krisen rammer
– pædagogiske og psykologiske
perspektiver på krisehåndtering

PPT nr. 3-2019

**Gammel kunnskap og ny viten:
perspektiver på krisepsykologi**

Af Atle Dyregrov

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLÆGGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Gammel kunnskap og ny viten: perspektiver på krisepsykologi



Krisepsykologi er et felt som skjøt fart i 1980-årene. En parallell utvikling skjedde i skandinaviske land, delvis som følge av arbeid med dagliglivets alvorlige krisehendelser, delvis som følge av større katastrofale hendelser. Bevisstheten rundt oppfølging av rammede grupper skjedde fordi psykologer og andre begynte å arbeide på feltet, men også fordi direkte rammede fremmet sine behov gjennom organisasjoner og støttegrupper. I artikkelen presenteres viktigheten av god informasjon som går hånd i hånd med god og nær omsorg og støtte. Nyere forskning, spesielt omkring hukommelse gir muligheter for å dempe emosjonell minnesdannelse og for terapeutisk intervensjon senere. Veier videre eksemplifiseres ved noen områder hvor kriseintervensjon møter utfordringer: oppfølging over tid, nettverkstøtte, og tidlig anvendelse av terapi.

Af Atle Dyregrov, professor, Senter for Krisepsykologi, Universitetet i Bergen

Litt norsk og skandinavisk historie

Tidlig på 1980-tallet var krisepsykologi et ukjent begrep på skandinavisk område. Som fagfelt var det ikke etablert, selv om krisebegrepet var kjent og nytet i samband med forventede stressfylte overganger i livet og akutte hendelser. Toneangivende psykiatere i Norge, Arne Sund og Lars Weisæth, hadde introdusert begrepet katastrofepsykiatri i 1970-årene og etablert et Kontor for katastrofepsykiatri ved Universitetet i Oslo. Dette var delvis et militært kontor og opptatt av forskning i forbindelse med krig og ulykker.

Krisepsykologi vokste ut av praktisk, klinisk arbeid nært de som ble rammet av ulike alvorlige kriser. Flere prosjekter tilknyttet Barneklubben, Haukeland sykehus i Bergen ble viktige for at feltet ble etablert. Prosjektene ledet av psykologene Magne Raundalen, Atle

Dyregrov og Elin Hordvik rettet seg mot foreldre som opplevde barns livstruende sykdom og død. Dette arbeidet fikk stor betydning for tenkningen rundt kriseintervensjon i Norge (Raundalen & Dyregrov, 1983 a, b).

I 1980 skjedde ulykken med kantrinken av oljeplattformen Alexander Kielland i Nordsjøen der 123 mennesker ble drept. Svært mange av dem var unge småbarnsfedre. Fra vår lille gruppe på Haukeland sykehus ble det tatt kontakt med den politiske ledelsen i Norge for å få igangsatt et oppfølgingsarbeid for etterlatte familier, men det førte ikke fram. Tiden var ikke moden. Men, denne ulykken og flere andre i løpet av 1980-tallet medførte øket interesse for feltet. I 1985 ble det første kurset i katastrofepsykologi holdt på Nordisk psykologkongress i Göteborg.

Selv om ikke de rammede av ulike krisehendelser, «brukerne», var pådriver i denne utviklingen, var de erfaringene vi fikk formidlet fra kriserammede selv med som grunnlag i de anbefalinger vi ga om oppfølging av kriserammede. Erfaringene ble supplert av besøk til steder i USA som hadde opplevd katastrofehendelser, hvor behovet for bedre oppfølging av grupper av rammede (etterlatte, overlevende, hjelpere) ble fremhevet. Faglige artikler om både konsekvensene av ulike krisehendelser og hvordan oppfølging kunne organiseres for både direkte berørte og hjelpere ble publisert (Dyregrov, 1983; 1985 a, b). I Europa samlet fagfolk med interesse for traumer og kriser seg til en konferanse i Lincoln (UK) i 1988 som ble gjentatt annet hvert år. I 1993 etablerte vi European Society for Traumatic Stress da konferansen ble holdt i Bergen.

Kliniske erfaringer fra barns møte med skolen ved alvorlig sykdom og død ble viktige for å endre situasjonen for barn i slike situasjoner og for å bidra til et «klimaskifte» på kriseområdet. Rundt 1980 ble barn vanligvis ikke inkludert i ritualer, deres besøk til syke søsken eller foreldre på sykehus var ikke ønsket, og døde et skolebarn ble pulten båret ut og dødsfallet sjeldent markert i skolen. Som psykologer ble vi forskrekket over den manglende anerkjennelsen av barns behov. Vi møtte denne utfordringen med å arrangere lærerkurs over hele Norge for å bevisstgjøre skolens ansatte på hvilket ansvar de hadde for å forstå og møte barns sorg. En parallell utvikling skjedde i Danmark hvor psykologen Anne Jacobsen tidlig spredde kunn-

skap om barn og sorg, senere fulgt opp med glimrende skolemateriell fra Per Bøge og Jes Dige i Kræftens Bekæmpelse. I Sverige ble temaet barn i sorg satt på agendaen av Karin Edenhämmer i Rädde Barnen.

I Danmark ble Krisepsykologisk Enhed etablert ved Rikshospitalet i 1985 hvor Anders Korsgaard Christensen tidlig engasjerte seg i arbeid for dem som opplevde belastende jobbsituasjoner (ran, vold), alvorlig sykdom, og ulykker. Han var også en viktig pådriver for opprettelsen av en spesialitet i psykotraumatologi i Dansk psykologforening.

Utviklingen av krisepsykologien i Norge var nært knyttet opp mot arbeidet for kriserammede barn, men også mot den oppmerksomhet som større hendelser ga området. I Norge skjedde det på 1980-tallet flere større ulykker hvor oppfølgingen av ulike rammede grupper fikk stor oppmerksomhet. Et snøskred drepte 16 soldater i 1986. Samme år døde 14 mennesker i en katastrofebrann på et hotell. I 1988 ble 36 mennesker drept i en flyulykke i Nord-Norge og kanskje viktigst; i august 1988 ble 12 barn og 4 voksne drept i en bussulykke i Måbødalen i Norge. Ulykken rammet svenske skolebarn på skoletur og oppfølgingen av ulykken fikk stor oppmerksomhet i Sverige, hvor de ble oppmerksom på hvor langt Norge var kommet i å gi krisehjelp. Dette betød et løft i svensk organisering av hjelp og oppfølging etter alvorlige krisehendelser.

Siden fulgte større ulykker som ga stor oppmerksomhet rundt kriseoppfølging og plasserte feltet på kartet i Skandinavia. Det er nok å tenke på

Scandinavian Star katastrofen, Partnair-flyulykken utenfor Hirtshals, Estoniaulykken, Tsunamien i Syd-øst Asia, flyulykken ved Milano (SAS), og terroren i Norge i 2011. Etter slike ulykker har det blitt dannet støttegrupper som har kjempet i gjennom endringer i offentlig organisering og oppfølging av rammede. Mindre synlig for offentligheten, men av like stor betydning har ulike støtteforeninger vært, for eksempel etter barnedødsfall, trafikkdødsfall og selvmord. Disse har synliggjort ulike grupper med behov for støtte, samt organisert tiltak som sikrer likepersonsstøtte. Nylig har jeg publisert en ny utgave av boken «Katastrofepsykologi» som oppsummerer gode tiltak for ulike grupper rammede (Dyregrov, 2018).

Akademisk interesse

Parallelt med fremveksten av ulike typer støtteforeninger og støttegrupper, har feltet også blitt viet mer akademisk interesse. Posttraumatiske stresslidelser kom inn i DSM-systemet (den amerikanske psykiaterforeningens diagnostiske system) allerede i 1980 som følge av oppmerksomheten rundt amerikanske veteraner fra Vietnamkrigen. Det resulterte i mye mer forskning rundt traumer. Siden sorg ikke har vært en diagnose, har forskningsinteressen her vært mindre, men i senere år har den tatt seg opp. Danmark har som første land i Skandinavia fått et nasjonalt sorgsenter i 2017 (<https://bornungesorg.dk/om-det-nasjonale-sorgcenter/>). I 2018 er forlenget sorg kommet inn som en ny diagnose i verdens helseorganisasjons diagnostiske system (ICD11). Dette vil sannsyn-

ligvis øke forskningsmengde og bredde på sorgområdet.

Historisk har prinsipper utviklet innen militærpsykiatri og arbeid mot somatiske tilstander vært lagt til grunn for oppfølging. Blant disse prinsipper er tidlig hjelp til rammede, hjelp nær der hendelsen har skjedd (i krig: frontlinjene) eller hjelp som strekker seg ut mot de som er rammet, og bruk av forventninger om at det skal gå bra. Undersøkelser av hva «brukere» ønsker av hjelp viser stort sammenfall med disse prinsippene. Brukerne ønsker tidlig hjelp, hjelp som er oppsøkende, kontinuitet i hjelpen, hjelp som varer over tid, og om de har barn, hjelp til barna (K. Dyregrov, 2003). I det følgende vil enkelte viktige aspekter ved moderne krisepsykologi vektlegges.

Betydning av god informasjon i krisesituasjoner

Prinsippene som ligger til grunn for vår hjelp er altså ikke nye, men gammel erfaring. Det er enkle prinsipper, men de kan likevel være vanskelig å omsette i den hjelp som gis i hverdagen. Et forhold som i mindre grad er omtalt i eldre litteratur om kriser, er hvor viktig informasjon er i en krisesituasjon. Enten det gjelder en katastrofehendelse eller en hendelse som rammer en enkelt familie vil rammedes opplevelse av tidlig krisehjelp bestemmes av hvor rask og god informasjon de får. Fordi tidsopplevelsen endres når en venter på informasjon i en krisesituasjon, kan selv kort tid kjennes som lang. Samtidig skjerpes alle sanser når en viktig situasjon oppstår for oss og vi blir svært sensitive i forhold til hvordan vi møtes av hjelpere i situa-

sjonen. Det betyr at god krisehjelp vil kjennetegnes av rask og god formidling av informasjon på en menneskelig godt ivaretakende måte (Dyregrov & Regel, 2012). Mange krisesituasjoner kjennetegnes av nokså kaotiske forhold i starten, med mangelfull informasjon om hva som har skjedd. Fra et fravær av informasjon, kan så både rammede og hjelpeapparat oversvømmes av informasjon. Det kan være vanskelig å skille sann fra falsk (rykter) informasjon. Samtidig kan det oppstå spenning fordi media og internett formidler informasjon uten de samme krav som politiet stiller til riktighet før informasjon formidles (f.eks. om dødsbudskap). Organisasjoner må forholde seg til godkjent informasjon og det oppstår lett frustrasjon over mangel på informasjon fra ansvarlige innen politi og hjelpeapparat. I dette farvannet skal mennesker ivaretas på best mulig måte.

I forhold til barn er informasjonsaspektet ofte dårligere ivaretatt enn for voksne. Dette til tross for at barn ofte trenger mer informasjon enn voksne for å forstå hva som har skjedd eller skjer. De mangler erfaring som gjør at de kan ordne hendelsen langs en tidslinje selv og de kan mistolke eller misforstå de de hører fra voksne eller fanger opp fra media. Voksne undervurderer barns behov for å vite, både etter større hendelser og etter dagliglivets krisehendelser. Et eksempel illustrerer dette.

Et jord- og steinskred går om natten under svært dårlige værforhold. To blir drept umiddelbart, mens en toåring senere dør av skadene. Mange må midlertidig evakueres til et

hotell. Kommunen arrangerer flere informasjonsmøter for de voksne, blant annet møte med en geolog som forklarer hvilken risiko det er for nye skred og med kommunale representanter som forteller hva som nå vil bli gjort av skredsikring. Så arrangeres to møter for foreldre til de mange barna som er evakuert. På disse møtene spør foreldre om det er normalt at barn går på Internett for å lese om ulykken. Ingen har tenkt på barnas informasjonsbehov. Ingen møter for dem med geolog. De ble overlatt til seg selv med å sette sammen og gi struktur til sine opplevelser.

Nyere forskning og gradvis erfaringsoppbygging

Det er vanskelig å gjennomføre forskning over tidlig intervensjon. Det er ikke umulig, men både etiske og praktiske forhold gjør dette vanskelig. Vi blir avhengige av å systematisk bygge på erfaringer innhentet fra rammede, men også ved å benytte laboratoriestudier og lære systematisk fra erfaringer og tilbakemeldinger fra rammede. Ved å ekstrapolere fra ulike studier som tangerer kriseområdet, kan vi forbedre intervensjoner.

Et eksempel er bruk av den kunnskap som er hentet fra hukommelsesforskning. Emily Holmes og hennes forskningsgruppe har på grunnlag av laboratoriestudier gitt et viktig bidrag til tidlig kriseintervensjon. De har utviklet det som kan kalles en kognitiv vaksine ved å nytte kunnskap om hukommelse kombinert med nye og spennende intervensjonsmetoder. Deres teoretiske utgangspunkt har vært at

hjernen bruker +/- 6 timer på å konsolidere et minne og at dette krever kognitive ressurser. Ved å belaste arbeidsminnet med oppgaver som krever kognitiv kapasitet kan konsolidering av et traumatisk minne forstyrres, med svekket emosjonell intensitet som resultat. Først utførte de laboratorieforskning hvor deltagerne (studenter) fikk se en film som av de fleste oppleves som svært sterk (traumatisk) før de fordelte deltagerne på en eksperimentgruppe og en eller flere kontrollgrupper. De lot eksperimentgruppen spille Tetris, et dataspill som krever bruk av ressurser i hjernens visuelle områder. De spilte i en 10 minutters periode tretti minutter etter at de så filmen, mens kontrollgruppen enten forholdt seg rolig eller gjennomførte en annen aktivitet. De viste at antall flasbacks fra traumefilmen ble redusert i Tetrisgruppen, men ikke i kontrollgruppen(e) (Holmes, James, Coode-Bate, & Deeprose, 2009; Holmes, James, Kilford, & Deeprose, 2010). Senere har de gjennomført studier blant kriseramede som viser samme positive virkning. Dette er vist etter ulykker som resulterte i sykdomsinnleggelse (Iyaduray et al., 2017) og etter stressfulle fødsler (Horsch et al., 2017). Selv om dette ikke gjør at en kan be mennesker som opplever en krisesituasjon om å gå å spille Tetris, har klinikere kunnet rådgi foreldre om å la barn se på film eller spille data i etterkant av hendelser, slik de gjerne naturlig gjør. Dette i motsetning til alvorlige, dype samtaler med barna like etter krisehendelser.

Kunnskapen om tidsvinduet rundt konsolidering av minner betyr også at

alt som er med på å styrke denne konsolideringen kan motvirkes i en tidlig fase. Forskning viser også at når (traumatiske) minner reaktiveres, slik det skjer i terapi, så er de labile i en periode. Terapeutiske intervensjoner som forstyrrer rekonsolideringsprosessen kan dempe posttraumatiske reaksjoner. Akkurat hva som skjer er ikke helt klargjort enda, men det antas at arbeidsminnet ikke har tilstrekkelig med ressurser til å konsolidere den emosjonelle delen av minnet (Kredlow, Eichenbaum, & Otto, 2018; Visser, Lau-Zhu, Henson, & Holmes, 2018). I terapi har en begynt å virkelig overbelaste arbeidsminnet for å bevirke en endring i posttraumatiske vansker. Det siste som er lansert er ulike måter å kombinere bevegelse, f.eks. gå på et rullebånd, med eksponering for en virtuell interaktiv virkelighet tilpasset det traumet som man har opplevd. I tillegg lar en klienten følge en ball som beveger seg frem og tilbake med øynene (eye-movement), mens en går (Nijdam og Vermetten, 2018). Kombinasjonen av ulike metoder kalles 3MDR som henspiller på EMDR. Ulike perspektiver og et kasuseksempel finnes kort beskrevet i Nijdam og Vermetten (2018). Det er jo meget mulig å tenke seg at varianter av denne fremgangsmåten kan nyttes tidlig etter eksponering for en potensiell traumatisk hendelse, altså innenfor 6-timers vinduet for konsolidering av et minne. Dette vil nok bli gjenstand for uttesting i årene som kommer. Uansett om forklaringen knyttet til forstyrrelse av minneskonsolidering er helt korrekt, åpner slike kombinasjoner av metoder muligheter for tidlig bruk etter traumatiske hen-

delse og senere, slik at den emosjonelle intensiteten av et minne kan dempes.

Kroppslig aktivering styrker konsolidering. Ved å dempe aktivering, reduseres styrken i minnene som fester seg. For både voksne og barn kan god, menneskelig omsorg og varme virke dempende på aktivering. Vår kliniske erfaring fra større krisesituasjoner viser også at hyppig informasjon fra autoritative kilder har en dempende effekt på enkeltindivider og grupper. Et eksempel på hvordan dette håndteres:

Etter terroren i In Amenas i 2012 (5 drepte og 17 skadede fra Statoil, nå Equinor) og etter en helikopterulykke som tok 13 liv i 2016, innførte vi samme informasjonsstrategi i dagene som fulgte hendelsene. På dagtid var det informasjonsmøter for de mange pårørende som var samlet hver eneste time. Dette til tross for at det var lite ny informasjon som ble tilgjengelig mellom flere av disse tidspunktene. En slik strategi demper uro, formilder omtanke fra de som møter de rammede og oppleves som viktig av de som er samlet. Informasjonsverdi kan være lav, mens omsorgsverdien er høy. Lavere aktivering antas å gi mindre sterke negative minner.

Det er kjent at søvn også er med å konsolidere minner (Hu, Stylos-Allan, & Walker, 2007; Wagner, Hallschmid, Rasch, & Born, 2006). Vi kan ikke aktivt gi folk råd om å søvndeprivere seg selv, men vi kan fraråde bruk av sove medisiner første natt, og vi kan redusere bekymring for at de ikke får sove. Vi vet også at de som ikke opplever god

smertedempning etter en fysisk skade opplever mer posttraumatiske plager (van Meijel et al., 2018; Holbrook, Gallarneau, Dye, Quinn, & Dougherty, 2010). God smertedempning er derfor også en god intervensjon for dempning av psykologiske etterreaksjoner.

Hvor går veien videre?

Veien videre blir sikkert ulik i ulike land. Skandinaviske land er ulike, selv om vi har felles verdier. I Danmark har mye av krisepsykologien hatt et sterkt innslag av privat næringsvirksomhet, hvor psykologer gjennom forsikringsordninger får betalt for et visst antall oppfølgingstimer. I Norge har alle kommuner kriseteam som assisterer etter plutselige dødsfall og andre krisehendelser, i tillegg til at både private avtalespesialister og spesialisthelsetjenesten tidlig kan bli koblet på i oppfølging. Ulike system gir ulike muligheter og ulike utfordringer for fremtiden.

Til nå har fokus i kriseintervensjon vært på tidlig hjelp, ofte til enkeltpersoner. Mange hendelser rammer lokalsamfunn og fordrer andre intervensjoner enn for enkeltmennesker som rammes. Modeller for intervensjon etter hendelser som rammer lokalsamfunn sterkt trengs å utvikles mer enn nå. Dette gjelder både tidlig intervensjon og hjelp over tid. Større hendelser krever kollektive tiltak hvor grupper av rammede kan møtes, utveksle erfaringer og få informasjon, bearbeide hendelsen i smågrupper og utvikle gode mestringsressurser for å håndtere nåtid og fremtid (Dyregrov, Dyregrov, Straume, & Grønvold Bugge, 2014)

Oppfølging over tid

En av de største utfordringene som finnes på kriseområdet i dag er hvordan vi skal sikre at de som trenger oppfølging over tid får det, og hvordan overlevering skal skje fra de som gir krisehjelp til de som står for langtidsoppfølging når det er nødvendig. Fordi så mange opplever stor tillit til de som kommer til med tidlig hjelp, kan det være vanskelig å overføre tilliten til de som skal ha ansvar for oppfølging over tid. En mulig løsning er at begge typer hjelp gis av samme personer, noe som vil kreve at kunnskap om terapeutiske metoder kan gis gjennom lavterskeltilbud eller av de som kommer inn i akuttfasen. Uansett er det viktig med mer fokus på langtidsoppfølging fordi mange av de rammede er misfornøyd med at hjelp og støtte både fra sosialt nettverk og profesjonelle hjelpere mobiliseres akutt, men ikke er tilgjengelig når hverdagen kommer og mange får det verre. De kan fortelle at de til og begynne med var beskyttet av sjokket, men når sjokket avtok var det ikke noen der til å hjelpe dem.

Ivaretagelse av familier

En annen utvikling jeg imøteser med spenning er bedre ivaretagelse av familier. Krisehendelser skjer ikke i et vakuum. De rammer familier. Enten det er en voldtekt av et ungt menneske, en forelder som dør, eller en bank som ranes, så gir dette konsekvenser ut over enkeltpersoner. Det skaper endringer i rollefordeling, familiesamspill (kommunikasjon og samhold), og samspill mellom generasjonene. Også her kan det umiddelbare sjokket gjøre at konsekvensene for samspill i famili-

en først kommer til syne senere. Mitt kjennskap er spesielt stort til hva som skjer om noen dør plutselig i familien. Over tid er det svært vanskelig for mange å opprettholde samtale om den som er død uten assistanse. Det går lettere å kommunisere om hva den døde likte å spise eller vedkommendes favorittsteder, enn om savnet av den døde eller påtrengende minner som plager en. Vi trenger en krisepsykologi der psykologer og andre kan tilby samtaler om hvordan det som har skjedd påvirker familiekommunikasjon over tid, om hvordan roller kan redistribueres, hvordan ulikt savn blant familiedemedlemmene kan leves med, hvordan familiemedlemmer kan støtte hverandre m.m. Slike samtaler er for tunge å ta uten ytre støtte. Familiemøter trenger ikke være mange, men trengs i det første året etter et dødsfall. De kan ikke påtvinges familier, men være der som et tilbud for dem som trenger det.

Nettverksstøtte

Nesten uansett hvilket område som undersøkes med hensyn til mental (u) helse så fremheves den positive betydningen av god sosial støtte. Manglende sosial støtte er assosiert med flere og mer alvorlige problemer, mens tilstedeværelsen av god sosial støtte virker beskyttende. Samtidig er det få opplegg som direkte har forsøkt å optimalisere slik støtte. Dette er et område som jeg forventer vil bli bedre utviklet. Vi har utviklet en modell for nettverksstøtte hvor det arrangeres et møte med nære venner og familie (supplert med eventuelle viktige ressurspersoner som lærer, barnehagelærer) for å gi informasjon om vanlige reaksjoner, og for å

diskutere hvordan familien kan støttes på kort og lang sikt. Modellen ble utviklet for plutselige dødsfall, men har vært prøvd ut med gode resultater i familier hvor en av foreldrene har en alvorlig kreftsykdom (Hauken, Senne-
seth, Dyregrov, & Dyregrov, 2015; Sen-
neseth et al., 2017). For ungdommer hvor vennegruppen er svært viktig, kan det være spesielt viktig å mobilisere god vennestøtte.

Hvor tidlig skal terapi anvendes?

I kriseintervensjon vektlegges det at de rammede ikke er pasienter som trenger terapi, men mennesker som kan nyttiggjøre seg god informasjon formidlet i et «varmt» klima. Vi skaper strukturer rundt dem som kan hindre skjevutvikling, inkludert god informasjon om det mentale terrenget de beveger seg inn i. Samtidig er det uklare grenser mot terapi. For de som reagerer med umiddelbart svært sterke reaksjoner (kalt Acute Stress Disorder i DSM-systemet) kan terapeutisk arbeid være påkrevet fra starten av. Noen av de selvhjelpsmetoder som vi tidlig instruerer rammede i å bruke (se <https://www.krisepsykologi.no/informasjon-og-raad/selvhjelp/>) kan også nyttes i terapirommet i samspillet mellom klient og terapeut. I USA har en anvendt eksponeringsterapi allerede innen et døgn etter at mennesker har vært utsatt for en potensielt traumatisk hendelse (Rothbaum et al., 2012). Rothbaum og medarbeidere (2012) fant at etter trafikkulykker, fysisk vold og seksuelle overgrep resulterte tre ukentlige en-times sesjoner med eksponering i reduserte posttraumatiske

plager og depresjonssymptomer. Den første timen ble gjennomført innen de første timene etter hendelsen. Det problematiske med en så «aggressiv» bruk av terapi er jo at eventuell naturlig tilheling ikke får tid til å virke. EMDR er også anvendt tett innpå krisehendelsen (ulykken) (Gil-Jardiné et al., 2018). Ulike former for traumefokusert kognitiv atferdsterapi har blitt benyttet med god virkning noe senere, gjerne for de som fortsatt sliter etter en eller flere måneder har passert siden krisehendelsen (for en oversikt se Birur, Moore, & Davis, 2017).

Konklusjon

Vi har i de siste 40 årene utviklet en betydelig forbedret ivaretagelse av barn og familier etter alvorlige krisehendelser. Deres behov er anerkjent etter hendelser som rammer enkeltfamilier og etter større ulykker og katastrofer. God informasjon og varme og omsorg prioriteres i ivaretagelsen. Psykologisk kunnskap benyttes på ulikt vis for å optimalisere hjelpen og for å aktivere god nettverksstøtte. Likevel kan feltet videreutvikles slik at familier ivaretas enda bedre over tid og at vi forbedrer vår vurdering av hvem som trenger mer traume- og sorgterapeutisk hjelp. Mens vår terapeutiske hjelp til de som opplever posttraumatiske problemer er blitt betraktelig forbedret, er tiden kommet for et løft for de som utvikler komplisert sorg, både barn og voksne. Med anerkjennelsen av forlenget sorg som diagnose i ICD 11 er grunnlaget til stede for en større satsing på sorg innen forskning og terapeutisk oppfølging.

Referanser

- Birur, B., Moore, N. C., & Davis, L. L. (2017). An evidence-based review of early intervention and prevention of posttraumatic stress disorder. *Community Mental Health Journal*, 53, 183–201. doi:10.1007/s10597-016-0047-x.
- Dyregrov, A. (1983). Stress-reaksjoner hos hjelpere. *Tidsskrift for Norsk Psykologforening*, 20, 674–679.
- Dyregrov, A. (1985a). Psykologens arbeid i kriser og katastrofer: Hører vi hjemme i slikt arbeid? *Tidsskrift for Norsk Psykologforening*, 22, 273–275.
- Dyregrov, A. (1985b). Krisehjelpsteam. *Tidsskrift for Norsk Psykologforening*, 22, 206–210.
- Dyregrov, A. (2018). *Katastrofe psykologi. Bergen: Fagbokforlaget. 3. utgave.*
- Dyregrov, A., Dyregrov, K., Straume, M., & Grønvold Bugge, R. (2014). Weekend family gatherings for bereaved after the terror killings in Norway in 2011. *Scandinavian Psychologist*, 1, e8. <http://dx.doi.org/10.15714/scandpsychol.1.e8>
- Dyregrov, A., & Regel, S. (2012). Early interventions following exposure to traumatic events—implications for practice from recent research. *Journal of Loss and Trauma*, 17, 271–291. DOI:10.1080/15325024.2011.616832.
- Dyregrov, K. (2003). *The loss of child by suicide, SIDS, and accidents: Consequences, needs and provisions of help*. Doctoral dissertation (dr. philos). HEMIL, Psychological Faculty, University of Bergen. ISBN 82-7669-099-8.
- Gil-Jardiné, C., Evrard, G., Al Joboory, S., Tortes Saint Jammes, J., Masson, F., Ribéreau-Gayon, R., ... Lagarde, E. (2018). Emergency room intervention to prevent post concussion-like symptoms and post-traumatic stress disorder. A pilot randomized controlled study of a brief eye movement desensitization and reprocessing intervention versus reassurance or usual care. *Journal of Psychiatric Research*, 103, 229–236. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2018.05.024>
- Hauken, M. A., Senneseth, M., Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2015). Optimizing social network support to families living with parental cancer: Research protocol for the Cancer-PEPSONE study. *JMIR Research Protocols*, 4(4), e142. <http://doi.org/10.2196/resprot.5055>
- Holbrook, T. L., Galarneau, M. R., Dye, J. L., Quinn, K., & Dougherty, A. L. (2010). Morphine use after combat injury in Iraq and post-traumatic stress disorder. *The New England Journal of Medicine*, 362(2), 110–117. doi:10.1056/NEJMoa0903326
- Holmes, E. A., James, E. L., Coode-Bate, T., & Deeprose, C. (2009). Can playing the computer game “Tetris” reduce the build-up of flashbacks for trauma? A proposal from cognitive science. *PLoS ONE* 4(1): e4153. doi:10.1371/journal.pone.0004153
- Holmes, E. A., James, E. L., Kilford, E. J., & Deeprose, C. (2010). Key steps in developing a cognitive vaccine against traumatic flashbacks: Visuospatial Tetris versus verbal pub quiz. *PLoS ONE*, 5 (11), 1–9.
- Horsch, A., Vial, Y., Favrod, C., Harari, M. M., Blackwell, S. E., Watson, P., & et al. (2017). Reducing intrusive traumatic memories after emergency caesarean section: a proof-of-principle randomized controlled study. *Behaviour Research and Therapy*. doi:10.1016/j.brat.2017.03.018.
- Hu, P., Stylos-Allan, M., & Walker, M. P. (2007). Sleep facilitates consolidation of emotional declarative memory. *Association for Psychological Science*, 7, 891–898.
- Iyadurai, L., Blackwell, S. E., Meiser-Stedman, R., Watson, P. C., Bonsall, M. B., Geddes, J. R., ... Holmes, E. A. (2017). Preventing intrusive memories after trauma via a brief intervention involving Tetris computer game play in the emergency department: a proof-of-concept randomized controlled trial. *Molecular Psychiatry*. <https://doi.org/10.1038/mp.2017.23>
- Kredlow, M. A., Eichenbaum, H., & Otto, M. W. (2018). Memory creation and modification: Enhancing the treatment of psychological disorders. *The American Psychologist*, 73(3), 269–285. <https://doi.org/10.1037/amp0000185>
- Nijdam, M. J., & Vermetten, E. (2018). Moving forward in treatment of posttraumatic stress disorder: innovations to exposure-based therapy. *European Journal of Psychotraumatology*, 9(1), 1458568. <https://doi.org/10.1080/20008198.2018.1458568>
- Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1983a). Psykologisk intervensjon i familier med alvorlig syke barn; Terapeutiske virkemidler. Del I.

- Tidsskrift for Norsk Psykologforening*, 20, 13–18.
- Raundalen, M., & Dyregrov, A. (1983b). Psykologisk intervensjon i familier med alvorlig syke barn; Terapeutiske virkemidler. Del II. *Tidsskrift for Norsk Psykologforening*, 20, 61–69.
- Rothbaum, B. O., Kearns, M. C., Price, M., Malcoun, E., Davis, M., Ressler, K. J., Lang, D., & Houry, D. (2012). Early intervention may prevent the development of posttraumatic stress disorder: A randomized pilot civilian study modified prolonged exposure. *Biological Psychiatry*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.biopsych.2012.06.002>
- Senneseth, M., Dyregrov, A., Laberg, J., Matthiesen, S. B., Pereira, M., & Hauken, M. A. (2017). Facing spousal cancer during child-rearing years: The short-term effects of the Cancer-PEPSONE programme—a single-center randomized controlled trial. *Psycho-Oncology*, 26(10), 1541–1547. <https://doi.org/10.1002/pon.4329>
- van Meijel, E. P. M., Gigengack, M. R., Verlinden, E., van der Steeg, A. F. W., Goslings, J. C., Bloemers, F. W., ... Lindauer, R. J. L. (2018). The association between acute pain and posttraumatic stress symptoms in children and adolescents 3 months after accidental injury. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*. <https://doi.org/10.1007/s10880-018-9567-6>
- Visser, R. M., Lau-Zhu, A., Henson, R. N., & Holmes, E. A. (2018). Multiple memory systems, multiple time points: how science can inform treatment to control the expression of unwanted emotional memories. *Philosophical Transactions, R. Soc. B* 373: 20170209. <https://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0209>
- Wagner, U., Hallschmid, M., Rasch, B., & Born, J. (2006). Brief sleeping after learning keeps emotional memories alive for years. *Biological Psychiatry*, 60, 788–790.